Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
1ª Vara Cível da Comarca de Serra Talhada

R CABO JOAQUIM DA MATA, S/N, Forum Dr. Clodoaldo Bezerra de Souza e Silva, TANCREDO NEVES, SERRA TALHADA - PE - CEP: 56909-115 - F:(87) 39293586

Processo nº 0000209-25.2025.8.17.3370

AUTOR(A): J. P. D. O. L., MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

RÉU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

S E N T E N Ç A

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, devidamente qualificado nos autos, atuando em substituição processual do menor **J. P. D. O. L.**, também qualificado, ajuizou a presente ação civil pública de obrigação de fazer contra a **UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, igualmente qualificada, alegando, em suma, que o menor substituído, beneficiário do plano de saúde operado pela ré, é portador de Deficiência de Hormônio do Crescimento (CID E23.0) e necessita de tratamento urgente e contínuo com o medicamento Somatropina (Norditropin, Omnitrope ou Genotropin), conforme prescrição médica. Sustenta que a ré negou indevidamente a cobertura do fármaco, sob o argumento de se tratar de medicamento de uso domiciliar. Ao final, requereu basicamente, inclusive em sede de tutela de urgência, que a ré seja compelida a fornecer o medicamento prescrito, enquanto perdurar a necessidade do tratamento (ID 193346013).

A petição inicial veio acompanhada de documentos.

Proferiu-se decisão indeferindo o pedido de tutela provisória de urgência (ID 193508276). Contra essa decisão, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento (ID 194292919), ao qual foi concedida a tutela de urgência recursal pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco (ID 202615007).

Regularmente citada, a parte requerida apresentou defesa, em forma de contestação (ID 204514988), alegando, em síntese, a preliminar de inadequação da via eleita, por se tratar de direito individual heterogêneo. No mérito, sustentou, em resumo, a licitude da recusa, argumentando a ausência de obrigatoriedade de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, conforme previsão legal (art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98) e contratual. Pugnou pelo acolhimento da preliminar ou, no mérito, pela improcedência dos pedidos.

Este é o relatório.

Tudo bem visto e ponderado, **DECIDO**.

Torno sem efeito o ato de ID 204847015 por entender desnecessária a apresentação de réplica.

Cumpre esclarecer que o feito comporta julgamento abreviado, nos termos do art. 355, I, do CPC, pois desnecessária a dilação probatória para a oferta da prestação jurisdicional.

Antes de adentrar no mérito do caso em debate, passo à análise das questões processuais pendentes de apreciação.

A parte requerida arguiu preliminar de inadequação da via eleita, sustentando que a ação civil pública não seria o instrumento adequado para tutelar direito individual heterogêneo, como seria o caso dos autos.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

De fato, cabe ao Ministério Público para propor ação civil pública visando à proteção de direitos individuais indisponíveis, especialmente quando envolvem crianças e adolescentes ou pessoas com deficiência. A saúde de menor impúbere constitui direito individual indisponível de relevante interesse social, justificando a atuação ministerial.

No presente caso, trata-se da saúde de menor impúbere portador de deficiência hormonal, situação que claramente se enquadra na proteção de direito individual indisponível de criança/adolescente, o que autoriza a substituição processual pelo Ministério Público.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

Superadas essas questões, passo a enfrentar o mérito.

Sem maiores delongas, registro, desde logo, que o pedido formulado na exordial deve ser julgado **improcedente**.

Explico.

A controvérsia central reside na recusa da operadora de plano de saúde em custear o medicamento Somatropina prescrito para o menor J. P. D. O. L., portador de Deficiência de Hormônio do Crescimento (CID E23.0), **sob o fundamento de se tratar de <u>medicamento de uso domiciliar</u>**, excluído da cobertura obrigatória pelo art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

Embora a documentação médica comprove que o menor efetivamente apresenta a condição diagnosticada e que o tratamento com Somatropina pode ser benéfico para seu quadro clínico, a questão jurídica central **não reside na necessidade médica do tratamento**, mas **sim na obrigatoriedade de cobertura pela operadora de plano de saúde**.

Da mesma forma, **<u>não está em discussão</u>** nesse processo o tema relacionado à natureza (taxativo ou não) do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS.

O ponto de controvérsia consiste em saber **se o plano de saúde tem ou não o dever de fornecer ao paciente o <u>medicamento de uso domiciliar</u>**.

Pois bem.

O art. 10, IV, da Lei n° 9.656/1998 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) **exclui expressamente**, no âmbito da Saúde Suplementar, a obrigatoriedade de *"fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12"*.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento **atual** e **consolidado** de que os Planos de Saúde/Seguros Saúde (Saúde Suplementar) **podem excluir** de suas obrigações contratuais o fornecimento de medicamentos para **tratamento domiciliar**, **<u>exceto</u>** os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Reforçando este posicionamento, colaciono os seguintes julgados do STJ:

> "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. HOME CARE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. COBERTURA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. **2. No que diz respeito ao <u>medicamento de uso domiciliar</u>, a jurisprudência <u>dominante</u> e <u>mais recente</u> do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser <u>lícita</u> a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, <u>salvo</u> os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021).** (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro Ricardo Viilas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 3. Agravo interno improvido."
>
> (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.019.333/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023) (g.n.)
>
> "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ. **1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim**. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021). 2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida). **3. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.** 4. No âmbito do Sistema Único de

Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 5. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido. 6. Agravo interno não provido."

(STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022.) (g.n.)

Ainda de acordo com o STJ, *"[...]. o medicamento para tratamento domiciliar de que trata o art. 10, VI, da Lei 9.656/98 é* ***aquele prescrito pelo médico e que deve ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, sem necessidade de intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado, isto é, o medicamento diretamente adquirido nas farmácias e autoadministrado pelo paciente, cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar"*** (AgInt no AREsp n. 2.310.638/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023 [g.n.]).

Nada impede, obviamente, que seja realizada a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde ***(i)*** por liberalidade; ***(ii)*** por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou; ***(iii)*** mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS.

Na situação em apreço, contudo, *(i)* em consulta ao Bulário da ANVISA, foi possível constatar que os medicamentos "Omnitrope" ou "Norditropin" ou "Genotropin" são de **uso domiciliar**, e, por se tratar de fármaco **administrado via subcutânea**, **dispensa** o auxílio direto de profissional da saúde; e *(ii)* **há expressa disposição contatual excluindo** o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar (art. 30, "f", do Contrato - ID 204514995 - Pág. 12).

A proposto, decidindo **especificamente a respeito da Somatropina**, eis recente julgado do STJ sobre o tema:

"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE CRESCIMENTO. MEDICAMENTO. SOMATROPINA. USO DOMICILIAR. NEGATIVA LÍCITA DE COBERTURA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). **2. No caso em exame, o medicamento <u>somatropina</u> <u>não se inclui nas hipóteses de inclusão legal de cobertura de medicamento de uso domiciliar</u>, razão pela qual, em <u>não se tratando de medicamento de administração intravenosa</u>, a recusa de custeio ao tratamento, por parte do plano de saúde, não pode ser considerada abusiva**. 3. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.547.650/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) (g.n.)

Esse também é o entendimento firmando no âmbito do E. TJPE:

"DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. SOMATROPINA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. EXCLUSÃO DE COBERTURA PREVISTA CONTRATUALMENTE. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO - **Apelação interposta pelo Ministério Público de Pernambuco contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento somatropina a menor com baixa estatura idiopática** - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações entre consumidores e planos de saúde, com a ressalva de que a legislação específica da ANS prevalece quanto à cobertura de procedimentos e medicamentos - **<u>O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, mas a exclusão de medicamentos de uso domiciliar, como a somatropina, está prevista em lei e regulamentação específica, sendo lícita a negativa de cobertura pela operadora de saúde</u>** - Inexistência de ato ilícito ou abuso por parte da operadora. Danos morais não configurados - Recurso desprovido. Sentença mantida. Referências: Constituição Federal (art. 6º, art . 196), Lei 9.656/1998, Código de Defesa do Consumidor (art. 51), Recurso Especial nº 1.959 .202 (STJ)."

(TJ-PE - Apelação Cível: 00353946520228172001, Relator: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 22/10/2024, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes) (g.n.)

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à apelação, **mantendo a improcedência do pedido para que a operadora de saúde fosse obrigada a fornecer o medicamento Somatropina, utilizado para tratar deficiência de hormônio do crescimento**. O agravante sustenta que o medicamento é essencial para o tratamento do menor e que sua exclusão pelo plano de saúde é abusiva e ilegal. II. Questão em discussão. **2. A**

discussão envolve a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar por parte do plano de saúde, em especial o medicamento Somatropina, utilizado no tratamento de deficiência de hormônio de crescimento. A questão central consiste em saber se a negativa de fornecimento é legal à luz da legislação e das cláusulas contratuais. III. Razões de decidir. **3. A Lei 9 .656/98, art. 10, VI, exclui a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, salvo exceções para tratamentos antineoplásicos de uso oral, o que não se aplica ao caso. A cláusula contratual firmada entre as partes prevê expressamente a exclusão de cobertura para medicamentos domiciliares, o que está em conformidade com a legislação vigente.** 4. A jurisprudência pacífica sustenta que a negativa de fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, quando respaldada por cláusulas contratuais e pela legislação, não constitui prática abusiva. No presente caso, não há indicação de que o tratamento em questão exija internação hospitalar ou urgência/emergência, o que excluiria a obrigação do plano de saúde de custear o medicamento. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. **Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de medicamento para uso domiciliar por plano de saúde é válida quando amparada por contrato e legislação específica**. **2. A exceção prevista na Lei 9.656/98, art. 10, VI, aplica-se apenas a medicamentos antineoplásicos de uso oral e não abrange o medicamento Somatropina**." Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 10, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1376468/RJ, Rel . Min. Olindo Menezes, DJe 22/02/2016."

(TJ-PE - Apelação Cível: 00289911720218172001, Relator.: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 04/11/2024, Gabinete do Des . Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes) (g.n.)

Desse modo, considerando que o medicamento pleiteado é de uso domiciliar e não é enquadrável como *"antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim"*, mostra-se **inviável** acolher o pleito inicial.

É importante esclarecer que a presente decisão não refuta a importância do tratamento para a saúde do menor, nem questiona a prescrição médica. O que se analisa é exclusivamente a obrigatoriedade de cobertura pela operadora de plano de saúde, dentro dos limites estabelecidos pela legislação específica.

O menor e sua família mantêm a possibilidade de buscar o tratamento através do Sistema Único de Saúde (SUS), onde a Somatropina está disponível conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, ou mediante custeio particular.

Consigno, terem sido enfrentados todos os argumentos trazidos pelas partes capazes de influenciar na convicção do julgador, consoante art. 489, §1º, IV, do CPC. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça[1] (file:///D:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/05%20-%20Maio/260525/Senten%C3%A7a.IMP.plano%20de%20sa%C3%BAde.medicamento.uso%20domiciliar.somatrop decidiu que *"[...]. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. [...]"*.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da demanda para **JULGAR IMPROCEDENTE** o pedido formulado na petição inicial.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Intimem-se.

Em sendo interposto recurso de **APELAÇÃO**, por não haver mais o juízo de prelibação nesta Instância (art. 1.010 do Código de Processo Civil), sem necessidade de nova conclusão, nos termos do art. 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil, **INTIME-SE** o(a) apelado(a) para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997 do CPC), **INTIME-SE** a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do CPC.

Caso sejam apresentadas contrarrazões, em sendo suscitadas preliminares, **INTIME-SE** o apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.009, § 2º, do Código de Processo Civil, manifeste-se acerca das referidas questões.

Após o prazo, com ou sem resposta, ex vi do disposto no § 3º do art. 1.010 do CPC, **REMETAM-SE** os autos ao E. Tribunal de Justiça de Pernambuco, independentemente do juízo de admissibilidade.

Depois de cumpridas todas as disposições contidas nesta sentença, sem novos requerimentos, **arquive-se**.

Serra Talhada/PE, data conforme o registro da assinatura eletrônica.

Diógenes Portela Saboia Soares Torres

Juiz de Direito

[1] (file:///D:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/05%20-%20Maio/260525/Senten%C3%A7a.IMP.plano%20de%20sa%C3%BAde.medicamento.uso%20domiciliar.somatrop
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

Assinado eletronicamente por: DIOGENES PORTELA SABOIA SOARES TORRES
26/05/2025 15:24:10
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 205224145

25052615241045200000199887731

IMPRIMIR GERAR PDF